ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y VÓLVULOS

DR. EDGARDO ARCIA

DIVERTICULITIS AGUDA

- TC abdominal con contraste IV: prueba de referencia (sensibilidad/especificidad >95%); la colonoscopia está contraindicada en fase aguda (riesgo de perforación).

Clasificación de Hinchey modificada.
Diverticulitis aguda.

Estadio		Descripción	Manejo
0		**Diverticulitis** clínicamente **moderada**	Conservador
I	Ia	**Inflamación** pericólica limitada **sin absceso**	Conservador
	Ib	**Inflamación** pericólica limitada **con absceso**	<2cm: Conservador >2cm: Drenaje percutáneo
II		**Absceso pélvico, retroperitoneal o a distancia**	<2cm: Conservador >2cm: Drenaje percutáneo
III		**Peritonitis generalizada**, sin comunicación con luz intestinal.	Cirugía urgente (Colectomía)
IV		**Peritonitis fecal**, con comunicación con luz intestinal.	Cirugía urgente (Colectomía)



ENFERMEDAD DIVERTICULAR NO COMPLICADA

- Diverticulosis: presencia asintomática de divertículos, muy frecuente con la edad (>60% en mayores de 80 años); la dieta rica en fibra es la principal medida preventiva.
- Diverticulitis no complicada: tratamiento ambulatorio con antibióticos orales en pacientes sin comorbilidades ni signos de alarma.

EPIDEMIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA

- Divertículos falsos (de pulsión): herniación de mucosa y submucosa por los puntos débiles donde penetran los vasos rectos.
- Más en sigma en occidente (colon derecho en asiáticos). Factores: dieta pobre en fibra, edad, obesidad, sedentarismo, tabaco y AINEs.

CLÍNICA DE LA DIVERTICULITIS

- "Apendicitis izquierda": dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre, leucocitosis y cambios del hábito intestinal; puede haber masa palpable.
- Síntomas urinarios sugieren contacto con la vejiga o fístula.

MANEJO SEGÚN HINCHEY

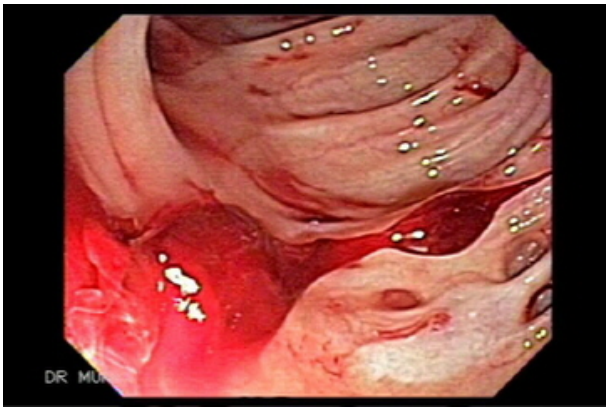
- No complicada: ambulatoria con dieta líquida; antibióticos solo en seleccionados (inmunodeprimidos, sepsis, comorbilidad).
- Hinchey I–II: antibióticos IV; absceso ≥4 cm: drenaje percutáneo guiado por TC.
- Hinchey III: lavado laparoscópico o resección. Hinchey IV: cirugía urgente.

HARTMANN VS. ANASTOMOSIS PRIMARIA

- Hartmann (sigmoidectomía + colostomía terminal + cierre del muñón rectal): pacientes inestables o con peritonitis fecaloidea.
- Resección con anastomosis primaria ± ileostomía de protección: pacientes estables y en buen estado general.

SANGRADO DIVERTICULAR

- Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en adultos: indoloro y autolimitado en ~80%; más frecuente en colon derecho.
- Colonoscopia; angio-TC o arteriografía si hay sangrado activo; cirugía si hay inestabilidad o recurrencia.



ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y VÓLVULOS

DR. EDGARDO ARCIA

FÍSTULA COLOVESICAL

- La complicación fistulosa más prevalente de la diverticulitis; díada patognomónica: neumaturia (gas por la uretra) y fecaluria.

SEGUIMIENTO

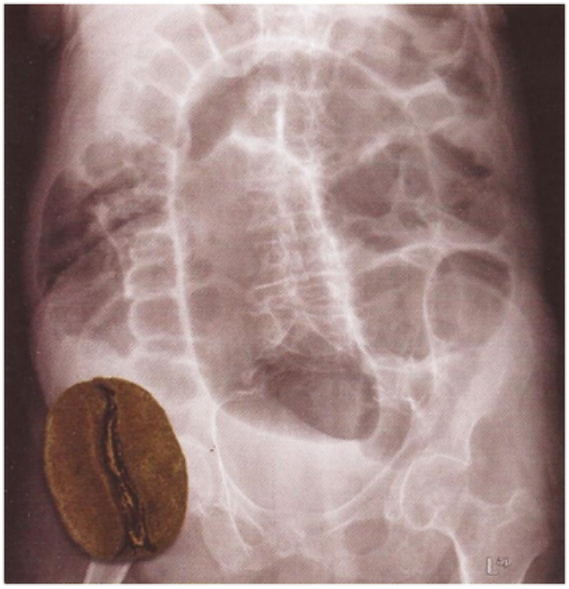
- Colonoscopia a las 6–8 semanas del episodio para descartar cáncer colorrectal (nunca en fase aguda).

CIRUGÍA ELECTIVA

- Individualizada; ya no se indica solo por el número de episodios.
- Indicaciones: diverticulitis complicada previa, fístula, estenosis, inmunosupresión o síntomas persistentes. Resección laparoscópica de sigma con anastomosis al recto alto.

VÓLVULO DE SIGMA

- Predomina en ancianos institucionalizados, encamados, con estreñimiento crónico o dolicocolon; distensión masiva e imposibilidad de expulsar gases/heces.
- Imagen patognomónica en "grano de café" o "signo de la omega" en la radiografía simple.



MANEJO SECUENCIAL DEL VÓLVULO DE SIGMA

- 1a línea (estable, sin isquemia/peritonitis): descompresión endoscópica + sonda rectal; sigmoidectomía electiva diferida en el mismo ingreso para prevenir recurrencia.
- 2a línea (isquemia, peritonitis o falla de devolvulación): cirugía urgente (Intervención de Hartmann) sin intento endoscópico previo.

VÓLVULO DE CIEGO

- Menos frecuente que el sigmoideo; manejo de entrada quirúrgico urgente (resección ileocecal o hemicolectomía derecha), dada la ineficacia endoscópica y el alto riesgo de necrosis precoz.



COMPLICACIONES DEL VÓLVULO

- Isquemia, gangrena y perforación: fiebre, peritonitis, contenido sanguinolento en la sonda o mucosa necrótica en la endoscopia → cirugía urgente (Hartmann).
- Recurrencia alta (>50%) tras la destorsión sin cirugía.